EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 66832
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-07-03 13:23:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: RAQUEL ESTHER NECOCHEA URRUTIA			RUN	: 9.592.846-3
F.Nac	: 28-09-1960	Edad	: 62 AÑOS, 9 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: POBL 11SEPT. EL MANZANO 1175			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 73435970		
Fecha Ingreso	: 2023-07-03	Fecha Egreso	: 2023-07-03 13:23:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Diagnosticos de Egreso:

-Sindrome Febril.
-ITU por E Coli Multisuceptible.
-Diabetes Mellitus 2 con mal control metabolico.
-Obesidad morbida
-HTA
-LCFA , se desconoce causa basal. (secual post covid?)
-Hiponatremia leve asintomatica (probable uso de diureticos)
-Hipotiroidismo

Farmacos (todos con mala adherencia)
-Losartan 1-1
-Amlodipno 5mg 1-0
-Carveidlol 3.125 mg cda 12
-Brexotide 2 puff cada 12
-Ipratorpio 2 puff cada 8
-Salbutamol 2 puff cada 8
-HCT 1-0
-NPH 40- 40
-Metformina 1 c 8 hrs
-Levotiroxina 150mcg x dia

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Consulta por cuadro de 3 a 4 dias de evolucion de escalofrios asociado a fiebre cuantificada.
Presenta sintomatologia respiratoria de forma cronica por mala adherencia a inhaladores , solo los ocupa SOS. (con indicacion de mantenerlos cronicos)
Sin focalidad en sus sintomas.
Se realiza estudio en servicio de urgencia donde finalmente se concluye que posee orina inflamatoria y

posteriormente
cultivo positivo para e coli multisuceptible.
Se inicia manejo con ceftriaxona con excelente respuesta clinica y de laboratorio.
PCR sobre 300 al inicio y actualmente en 200.
Al dia 3.7.2023 sin disfunciones organicas por lo que se encuentra en cnodiciones de ser trasladada a hodom para continuar con su manejo.

Examen Fisico de egreso
-Pa 135 / 79 FC 94
-T 36.5
-Sat 92 ambiental.
-vigil lucida cooepradora .
-Glasgow 15
-RR2t no ausculto soplos
-MP+ Sibilancias escasas expiratorias difusas , fr20x sin apremio respiratorio , no auscto crepitos.
-Abdomen BDI
-EEII sin edemas.

PLAN DE MANEJO:

Plan.

-Subo dosis de levotiroxina a 200mcg al dia (previmanete 150)
-Kinesioterapia respiratoria
-Mantener antibioticos 7 dias
-Reiniciar insulina por horarios segun indicacion de cesfam.
-reiniciar inhaladores de forma cronicas y no SOS.
-Control en su cesfam en 1 semana , HB glicda en 13 y tsh en 12 , para control metabolico y cronico.
-Control en urgencias sos.

INDICACIONES AL ALTA

1. Indicaciones:
2. -Regimen Diabetico
3. -Reposo Relativo.
4. -Ceftriaxona 2g ev al dia (ultima dosis 6.7.2023 inclusive)
5. -Brexotide 2 puff cada 12 horas.
6. -Ipratropio 4 puff cada 8 horas por 15 dias , luego disminuir a 2 puff cada 8 horas.
7. -Salbutamol 2 puff cada 8 horas.
8. -Suspender hidroclorotiazida
9. -Levotiroxina 200mcg al dia en ayunas
10. -kinesioterapia respiratoria.,
11. -resto de tratamiento cronico mantener.
12. -Control en 1 semana en su cesfam para ajuste farmacologica cronica (diabetes e hipotiroidismo)
13. -Control en urgencias SOS.

Control en: 7 días en CONSULTORIO DE ORIGEN

Jorge Andres Villa Flores
MEDICO TRATANTE
16178692-N

JEFE SERVICIO